Att navigera i det extraordinära

-Sjuksköterskans upplevelse av hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvården

Navigating the extraordinary

-The nurse´s experience of pediatric cardiac arrest within ambulance service

Författare: **Emma Gillberg och Therése Gunnstedt**

VT 2026

Examensarbete: *Avancerad nivå, 15 hp*

Huvudområde: *Omvårdnadsvetenskap*

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård OM024A

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Handledare: Helena Sjölin, Med Dr. Universitetslektor, Enheten för omvårdnad

Examinator: Karin Falk Brynhildsen, Docent, Universitetslektor, Enheten för omvårdnad

Sammanfattning

Bakgrund: Hjärtstopp hos barn är en ovanlig och livshotande händelse. Inom ambulanssjukvården definieras dessa larm som sällanhändelser vilket innebär en utmaning för sjuksköterskans kompetens. Trots lång yrkeserfarenhet riskerar den begränsade kliniska exponeringen att leda till osäkerhet, upplevd kompetensmässig utsatthet och en stark emotionell belastning.

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvården.

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ, induktiv design baserad på åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i två svenska regioner. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Som teoretisk ram användes Benners teori om klinisk kompetens.

Resultat: Analysen resulterade i huvudkategorin *"Att navigera i det extraordinära"* och fyra generiska kategorier: *Reaktioner vid utalarmering*, *Att bemästra kaos genom samspel och struktur*, *Emotionell belastning* samt *Bearbetning och finna ro efter insatsen*. Resultatet visar att utalarmeringen omedelbart triggar fysiologisk och emotionell stress. Sjuksköterskan använder algoritmer och automatisering som strategier för bibehållen handlingskraft och emotionell kontroll. Det kollegiala samspelet framstår som den viktigaste faktorn för trygghet, medan bristande samspel eller obalans i yrkesmässig erfarenhet skapar kognitiv belastning. Anhörigas emotionella reaktioner samt logistiska dilemman under transport, såsom valet mellan egen säkerhet eller adekvat vård, utgör etiska utmaningar.

Slutsats: Hjärtstopp hos barn tvingar sjuksköterskan att backa från en intuitiv expertnivå till en mer regelstyrd kompetensnivå enligt Benners modell. Den emotionella stressen hanteras genom att agera automatiserat och luta sig mot medicinska algoritmer under insatsen. Studien belyser hur dessa fall ofta lämnar djupare bestående avtryck än liknande händelser hos vuxna patienter.

Nyckelord: Ambulanssjukvård, Barn, Hjärtstopp, Sjuksköterskans upplevelser, Sällanhändelse

Abstract

Background: Pediatric cardiac arrest is a rare life-threatening event. Within the ambulance service, these calls are defined as low-frequency events, presenting a challenge to the nurse's competence. Despite extensive professional experience, limited clinical exposure risks leading to uncertainty, a perceived vulnerability in competence, and emotional burden.

Aim: The aim of the study was to describe the nurse's experience of pediatric cardiac arrest within the ambulance service.

Method: The study was conducted using a qualitative, inductive design based on eight semi-structured interviews with nurses working in the ambulance service across two Swedish regions. The material was analyzed using qualitative content analysis according to Elo and Kyngäs (2008). Benner's theory of clinical competence was used as the theoretical framework.

Results: The analysis resulted in the main category *"Navigating the extraordinary"* and four generic categories: *Reactions upon dispatch, Mastering chaos through interaction and structure, Emotional burden,* and *Processing and finding peace after the intervention*. The results show that the dispatch immediately triggers physiological and emotional stress. The nurse utilizes algorithms and automation as to maintain the capacity to act and keep emotional control. Collegial interaction emerges as the most important factor for safety, whereas a lack of interaction or an imbalance in professional experience creates a cognitive burden. The emotional reactions of relatives and logistical dilemmas during transport, such as choosing between personal safety or adequate care, pose significant ethical challenges.

Conclusion: Pediatric cardiac arrest forces the nurse to step back from an intuitive expert level to a more rules-bound level of competence according to Benner's model. Emotional stress is managed by acting automatically and relying on medical algorithms during the intervention. The study highlights how these cases often leave deeper, more lasting impressions than similar events involving adult patients.

Keywords: Ambulance care, Cardiac arrest, Low-frequency event, Nurse's experiences, Pediatric

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 1
   1.1 Hjärtstopp hos barn i ambulanssjukvården 1
   1.2 Sjuksköterskans roll och kompetens inom ambulanssjukvården 1
   1.3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv i sällanhändelsen 2
2. Problemformulering 2
3. Syfte 2
4. Metod 2
   4.1 Design 2
   4.2 Urval 2
   4.3 Datainsamling 3
   4.4 Dataanalys 3
   4.5 Forskningsetiska överväganden 4
5. Resultat 4
   5.1 Reaktioner vid utalarmering 5
      5.1.1 En emotionell utmaning 5
      5.1.2 Kroppslig stressreaktion och mental anspänning 6
      5.1.3 Ovisshet och tidspress under framkörning 6
      5.1.4 Förlust av professionell trygghet 7
   5.2 Att bemästra kaos genom samspel och struktur 7
      5.2.1 Kognitiv avlastning genom algoritmer och automatisering 7
      5.2.2 Betydelsen av det kollegiala samspelet 8
   5.3 Emotionell belastning 8
      5.3.1 Emotionell distansering för bibehållen handlingskraft 8
      5.3.2 Anhörigas förtvivlan som operativ belastning 9
      5.3.3 Prehospitalt dilemma 9
   5.4 Bearbetning och finna ro efter insatsen 9
      5.4.1 Från professionell skärpa till emotionell reaktion 10
      5.4.2 Emotionellt efterspel 10
   5.5 Att navigera i det extraordinära 10
6. Diskussion 11
   6.1 Metoddiskussion 11
   6.2 Resultatdiskussion 12
7. Slutsatser 13
8. Kliniska implikationer 14
9. Fortsatt forskning 14

Referenslista 15

1. Bakgrund

1. 1 Hjärtstopp hos barn i ambulanssjukvården

Under de tre senaste decennierna ses en betydande ökning av den totala överlevnaden för barn som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Faktorer som tidig hjärt-lungräddning (HLR), bevittnade hjärtstopp och kort responstid för ambulans är avgörande för överlevnad. Införandet av speciella behandlingsprotokoll (algoritmer) för utförandet av HLR på barn är troligtvis ytterligare en bidragande orsak till att överlevnaden förbättrats. Orsaker till hjärtstopp hos barn varierar beroende av ålder, sammantaget är plötslig spädbarnsdöd, hjärtsjukdom samt kvävning vanligast hos de yngsta barnen, därefter tillkommer med stigande ålder drunkning, olycksfall, suicid samt intoxikationer (Fovaeus et al., 2024). Nationella siffror visar att cirka 10 % av alla ambulansuppdrag involverar barn (Jepsen et al., 2019). En av utmaningarna inom ambulanssjukvården är hanteringen av så kallade sällanhändelser med potentiellt allvarliga konsekvenser för patienten. Hjärtstopp hos barn är en sådan händelse (Bäckström et al., 2024). Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige vilket stärker barnets rättigheter i hälso-och sjukvården. Där slås fast att barn har rätt till bästa möjliga vård och inga barn får diskrimineras. Barnets bästa ska alltid beaktas i alla åtgärder som rör barnet (Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, SFS 2018: 1197).

1. 2 Sjuksköterskans roll och kompetens inom ambulanssjukvården

Sjuksköterskan är ansvarig för den medicinska vården i ambulanssjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Larsson och Engström (2013) har sjuksköterskan en central och komplex roll i det prehospitala omhändertagandet. Inom ambulanssjukvården sker omhändertagandet i en prehospital miljö som kännetecknas av begränsade resurser, tidskritiska beslut och ofta ofullständig information om patienten. Den prehospitala miljön innebär dessutom att sjuksköterskan ofta arbetar med begränsat stöd och behöver hantera situationer självständigt eller i små team (Larsson & Engström, 2013). Hjärtstoppssituationer hos barn kräver avancerade färdigheter och snabb handläggning (Bäckström et al., 2024). Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) fastslår att personalen som bedriver hälso- och sjukvård prehospitalt ska ha den kompetens som krävs för att utföra uppdragen på ett korrekt och säkert sätt.
Optimala förutsättningar för barn som drabbats av hjärtstopp uppnås när sjuksköterskan är välutbildad, mentalt förberedd och tillämpar evidensbaserad behandling (Bettencourt et al., 2021). I och med att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård sällan utsätts för att vårda barn som är kritiskt sjuka leder detta till svårigheter i att upprätthålla kompetens, vilket kan leda till osäkerhet (Jeruzal et al., 2019). Bohström et al. (2017) fann att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplevde en ökad stress vid vårdande och omhändertagande av sjuka barn. Hjärtstopp hos barn beror i hög grad på respiratorisk- eller cirkulatorisk svikt (Djakow et al., 2025). Eftersom flertalet hjärtstopp orsakas av andningssvikt är korrekt luftvägshantering av största vikt (Fovaeus et al., 2024). Under det akuta omhändertagandet är en kärlaccess nödvändig för administrering av läkemedel, vilket enligt Bettencourt et al. (2021) ofta är ett kritiskt och utmanande moment. De belyser att läkemedelsdoser hos barn kräver individuella uträkningar baserade på vikt. Detta moment, kombinerat med hög stress vid hjärtstopp hos barn, ökar risken för felbehandling och kräver därför ett väl samordnat team för att nå ett optimalt resultat (Bettencourt et al., 2021). De praktiska utmaningarna sammantaget med den starka emotionella stressen ger en av de mest stressande situationer sjuksköterskor inom ambulanssjukvård kan utsättas för (Öberg et al., 2015).

1. 3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv i sällanhändelsen

Benner (1993) beskriver fem nivåer av klinisk kompetens: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Teorin bygger på att sjuksköterskans kompetens inte enbart vilar på teoretisk kunskap, utan utvecklas genom praktisk erfarenhet och reflektion. Enligt Benner krävs upprepad exponering för specifika kliniska situationer för att nå de högre stadierna, där sjuksköterskan går från att följa strikta regler till att agera utifrån en intuitiv förståelse för helheten. Benner menar att en sjuksköterska som uppnått expertnivå inom ett område kan återgå till en lägre nivå när den ställs inför ovanliga eller obekanta kliniska situationer. Vid sällanhändelser i akuta situationer blir teamets samlade erfarenhet avgörande för huruvida situationen hanteras metodiskt eller upplevs som kaotisk.

2. Problemformulering

Hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvård är ett ovanligt och livshotande tillstånd som kräver ett snabbt och korrekt omhändertagande. Samtidigt är det en av de svåraste och mest stressande vårdsituationer sjuksköterskan kan utsättas för. Kunskapen om hur sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i Sverige upplever dessa komplexa situationer är begränsad. Det finns därför ett behov av att fördjupa förståelsen för sjuksköterskans upplevelse vid omhändertagandet av barn med hjärtstopp inom ambulanssjukvård. Kunskap om dessa upplevelser kan bidra till utveckling av stöd och utbildningsinsatser som stärker sjuksköterskans kompetens och emotionella beredskap. Detta kan i sin tur skapa bättre förutsättningar för ett tryggt och säkert omhändertagande av barnet samt ett mer stödjande bemötande av anhöriga och genom detta bidra till en ökad vårdkvalitet.

3. Syfte

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvården.

4. Metod

4. 1 Design

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ, induktiv design och baserades på analys av textdata med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008).

4. 2 Urval

Studien genomfördes i två mellanstora regioner som innefattade såväl större städer som mindre orter och landsbygd vilket gav en kombination av varierande ambulansuppdrag gällande avstånd. Sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården med erfarenhet av omhändertagande av barn med hjärtstopp planerades att intervjuas. Både bekvämlighetsurval och snöbollsurval användes. Inklusionskriterier: Legitimerad sjuksköterska verksam inom ambulanssjukvården med erfarenhet av minst ett hjärtstopp på barn 0–18 år oavsett utgång. Svensktalande. Inget bortfall uppkom.

4. 3 Datainsamling

Ett informationsbrev om studien och dess syfte skickades ut till verksamhetschef i ambulanssjukvården i berörda regioner. Studiens genomförande godkändes av verksamhetscheferna. Fyra sjuksköterskor författarna visste hade deltagit vid ett omhändertagande av barn med hjärtstopp tillfrågades personligen om att delta i studien. Med hjälp av snöbollseffekt tillkom ytterligare sex sjuksköterskor villiga att delta i studien. Av dessa valdes de fyra första som visade intresse. Informationsbrev och samtyckesbrev distribuerades till de informanter som rekryterats. En provintervju genomfördes för att säkerställa att frågorna svarade mot syftet. Då frågorna ansågs vara relevanta för syftet inkluderades intervjun senare i studien. Totalt genomfördes åtta intervjuer, fyra intervjuer vardera. Intervjuerna spelades in med diktafon. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser i avskilda lokaler där inga störningsmoment förekom och varade mellan 14–27 minuter. Efter åtta genomförda intervjuer bedömdes att mättnad var uppnådd då innehållet blev repetitivt och inte bidrog till ytterligare fördjupning. Data samlades in genom semistrukturerad intervjumetod med en ”topic plan” (Polit & Beck, 2021), vilket innebär att intervjun kommer fokusera på det ämne forskaren är intresserad av men ger deltagaren mer frihet att berätta med sina egna ord med viss frihet i vilka följdfrågor som ställs. Intervjufrågorna formulerades och utgick utifrån syftet för att få informanterna att genom sina berättelser och erfarenheter beskriva situationer där de varit delaktiga i omhändertagandet av barn med hjärtstopp med fokus på upplevelsen (se bilaga 1). Studien bestod av semistrukturerade intervjuer som inleddes med en öppen fråga “Berätta om dina tankar gällande hjärtstopp hos barn?" och sedan huvudfrågor “Berätta om en situation där du varit delaktig i omhändertagandet av ett barn med hjärtstopp” samt följdfrågor som exempelvis “Vilka känslor väckte det hos dig?”.

4. 4 Dataanalys

Analysen av intervjuerna genomfördes med Elo och Kyngäs (2008) metod för innehållsanalys. I förberedelsefasen transkriberades intervjuerna ordagrant ner till text i direkt anslutning till avslutad intervju. Den transkriberade texten lästes i sin helhet flertalet gånger för att skapa en djupare förståelse av texten. I organiseringsfasen genomfördes en öppen kodning, vilket innebar att textavsnitt som relaterade till syftet identifierades. Vid behov reducerades texten genom att upprepningar eller stakningar togs bort medan kärnmeningen fortfarande bevarades. Därefter sattes en kod som representerade innebörden av kärnmeningen. Efter att allt material kodats sorterades koderna så att alla koder med samma innebörd grupperades tillsammans. Under organiseringsfasen utkristalliserades elva subkategorier, vilka genom abstraktion sammanfördes under fyra generiska kategorier för att sedan landa i en huvudkategori. Koderna granskades och jämfördes kontinuerligt mot originalmaterialet för att säkerställa att det representerade datamaterialet. Slutligen sammanställdes allt genom rapporteringsfasen där resultatet sammanställdes i ett analysschema (Tabell 1) för att tydliggöra kopplingen mellan rådata, koder och kategorier.

Tabell 1 Exempel på analysprocess

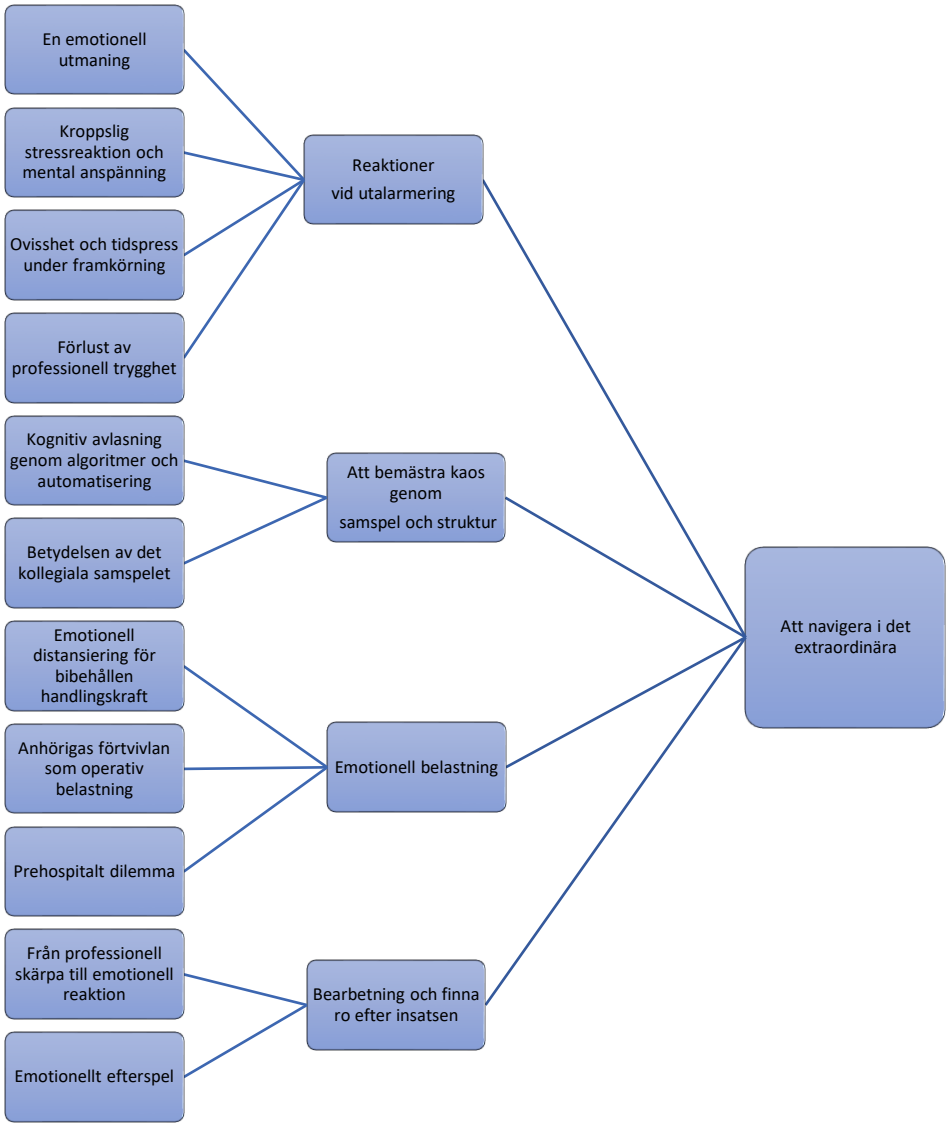
Intervjutext	Textavsnitt	Kod	Subkategori	Generisk kategori
”Jag hade också en kollega som jag kanske inte var helt synkad med. Det var ju en stressfaktor som ökade min stress väldigt mycket.”	En betydande ökning av stressnivå på grund av bristande samspel och kommunikation inom teamet	Teamrelaterad stress	Betydelsen av det kollegiala samspelet	Att bemästra kaos genom samspel och struktur

4. 5 Forskningsetiska överväganden

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de utan att uppge anledning när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De informerades om att allt insamlat material skulle hanteras konfidentiellt. Materialet i resultatet avidentifierades för att enskilda personer eller situationer inte skulle kunna identifieras. Efter avslutad studie raderas samtligt insamlat material. En ansökan om etisk prövning utfördes inte då studien utförs inom utbildning på avancerad nivå, inga journalhandlingar eller patienter deltog i studien (Etikprövningsmyndigheten, 2023). Under genomförandet av studien togs etiska principer i beaktning såsom samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta ämne riskerade att väcka emotionella reaktioner hos informanterna. Tid var avsatt för möjligheten att diskutera och reflektera efter intervjun om det önskades. Beredskap fanns i form av information om var informanterna kunde vända sig vid behov av ytterligare stöd. Författarna har tillsammans sammanställt, bearbetat, analyserat samt formulerat materialet och bidragit likvärdigt till arbetet vilket är självständigt formulerat. Båda författarna har förförståelse om ämnet genom flera års erfarenhet som sjuksköterskor inom såväl akut- som ambulanssjukvård. En kontinuerlig diskussion har förts genom hela processen där båda författarna varit väl medvetna och reflekterat över sin förförståelse för att minimera risken att påverka resultatet. Google AI har använts vid översättning av sammanfattningen till det engelska abstractet. Abstractet har därefter granskats och korrigerats av författarna.

5. Resultat

Analysen av sjuksköterskornas upplevelser av hjärtstopp hos barn resulterade i en huvudkategori *Att navigera i det extraordinära* och fyra generiska kategorier *Reaktioner vid utalarmering, Att bemästra kaos genom samspel och struktur, Emotionell belastning* samt *Bearbetning och finna ro efter insatsen*. Resultatet presenteras nedan under respektive generisk rubrik och illustreras med representativa citat från datamaterialet (se Figur 1 för översikt av abstraheringsprocessen från subkategorier till huvudkategori).



Figur 1. Abstraheringsprocessen från subkategorier till huvudkategori

5. 1 Reaktioner vid utalarmering

Informanterna beskrev den första fasen av uppdraget som en omedelbar och intensiv känslostorm av rädsla, stress, sorg, nervositet, osäkerhet och ångest som aktiverades redan vid utalarmeringen. Förutom de inre känslomässiga processerna tillkom fysiologiska stressreaktioner och yttre logistiska utmaningar. Flera informanter uppgav att utmaningen fördjupades av uppdragets lågfrekventa karaktär, i vilken den pediatriska patienten kräver specifik kunskap som frångår den kliniska vardagsrutinen.

5. 1. 1 En emotionell utmaning

Vetskapen om att larmet berörde ett barn beskrevs av informanterna som en omedelbar emotionell påfrestning. Flera av informanterna uttryckte en djup känsla av orättvisa inför situationen och ett känslomässigt motstånd då hjärtstopp hos barn inte överensstämmer med den allmänna uppfattningen om livets förväntade förlopp. En informant uttryckte:

"Det jobbigaste larmet. Det mest sällsynta larmet. Ett orättvist larm.
Jag önskar att ingen behöver åka på det." (5)

Informanterna beskrev att de upplevde en prestationsrelaterad oro. Inre mental beredskap och fokusering var en förutsättning för att kunna hantera den kommande kritiska situationen. De upplevde en press av att bära det yttersta ansvaret för omhändertagandet oberoende av tidigare yrkeserfarenhet. Några informanter beskrev att trots lång yrkeserfarenhet och en egen inre trygghet infann sig en osäkerhet vid hjärtstopp hos barn. Osäkerheten uppgav informanterna grundade sig i att händelsen sällan sker, så de aldrig känner sig säkra i situationen, samtidigt som viljan att prestera maximalt skapade en enorm inre stress.

"Det är en sådan sällanhändelse. Man vill ju att det ska bli rätt när man får de här larmen.
Jag tror det skulle vara konstigt om man inte kände oro" (8)

5. 1. 2 Kroppslig stressreaktion och mental anspänning

Flera informanter beskrev en utmaning i att hantera den inre stressen och samtidigt upprätthålla ett yttre professionellt lugn. De uppgav att uppdraget gav en fysisk stressreaktion genererad av oro och anspänning. Några informanter skildrade hur den extraordinära situationen framkallade en förhöjd koncentrationsnivå och ett skarpare fokus, vilket de inte får vid rutinuppdrag. De beskrev hur de redan under framkörningen påbörjade en intensiv mental förberedelse där de skapade scenarier och gick igenom medicinska algoritmer. De beskrev samtidigt hur det faktum att ett barn drabbats av ett livshotande tillstånd kunde ge ett mentalt brus under förberedelsen av den medicinska strategin.

"Man får ju den här klumpen i magen, att ändå hålla sig lugn…
det är så himla mycket tankar" (1)

5. 1. 3 Ovisshet och tidspress under framkörning

Flera informanter påtalade brist på, eller felaktig, förhandsinformation vilket lämnade sjuksköterskan i ett informationsvakuum. De beskrev känslan av att snabbt tvingas acceptera situationens allvar efter en initial fas av osäkerhet och statistiskt grundad misstro mot situationens allvar. En informant sa:

"Majoriteten av gångerna vi åker på det så är det ju inte det. Jag tror att man aldrig riktigt
tror att det är det förens man kommer fram…
För man fick ju typ ingen information på larmet" (7)

Informanterna beskrev hur det inte bara var det medicinska i situationen som var utmanande, utan även den logistiska komplexiteten. Flera beskrev en stress i att vilja ankomma till patienten så fort som möjligt, de skildrade ett ökat risktagande och åsidosättande av sin egen säkerhet under framkörningen. Två informanter berättade om en logistisk stress över att planera bästa ankomstväg för att därefter direkt vid ankomst etablera en plan för att skyndsamt ta sig ifrån platsen. De beskrev hur vardagliga moment såsom att ta med sig nödvändig utrustning upplevdes som en förlust av tid och ledde till ökad stress då behovet att få kontroll på situationen upplevdes stressande. En informant uttryckte:

"Vi ska bara hitta. Nu ska vi bara hitta fram fort som fan" (8)

5. 1. 4 Förlust av professionell trygghet

Samtliga informanter beskrev svårigheten att uppnå professionell trygghet vid omhändertagandet av barn med hjärtstopp relaterat till sällanhändelsen. En informant uppgav att vara van vid sjuka barn inte innebär en inre beredskap för att vårda döda barn. Flera informanter beskrev osäkerheten och den enorma rädslan för att göra fel, eftersom omhändertagandet av barn kräver en helt annan kognitiv skärpa då marginalerna är små och konsekvenserna av en felbehandling är stora. En informant beskrev förlusten av sin professionella trygghet i sällanhändelsen, trots lång erfarenhet som sjuksköterska skapade kraven på att prestera perfekt för barnets skull en osäkerhet. Flera informanter uppgav en rädsla för avgörande misstag och en upplevd nolltolerans för fel. En informant uttryckte:

"Även om vi åker på mycket barn så är det ju väldigt sällan vi åker på barn med livshotande tillstånd… det är ju inte den här vardagspatienten… och då kryper alltid den här osäkerheten in… man blir osäker fast jag är säker i mig själv" (1)

Några informanter uppgav att de kände sig trygga med ventilation och kompressioner. Flera informanter beskrev känslan av stress och oro över att oförutsedda praktiska och tekniska hinder skulle försvåra omhändertagandet. Några av informanterna lyfte sin oro inför att inte få in en infart eller att problem skulle uppstå vid luftvägshantering eftersom barn kräver teknisk anpassning och särskild försiktighet jämfört med vuxna. Informanterna uppgav varierande kunskap gällande dosering av läkemedel till barn, samtliga informanter ansåg att repetition av dosering krävdes inför omhändertagandet. En informant uttryckte:

"*Generellt om något inte flyter. Om vi inte får in luft, om det är något stopp som gör att vi inte får in luft, om vi inte får in någon infart, praktiska problem."* (3)

5. 2 Att bemästra kaos genom samspel och struktur

Väl på plats hos patienten skiftade fokus till att bemästra situationen och de starka intrycken genom kliniska och kollegiala strategier.

5. 2. 1 Kognitiv avlastning genom algoritmer och automatisering

För att kunna prestera medicinskt beskrev flertalet informanter hur de klev in i en roll och arbetade automatiserat och metodiskt. Genom att förlita sig på inövade algoritmer och ryggmärgsreflexer upplevde informanterna att de uppnådde en viss trygghet och kunde fokusera helt på uppgiften. Flera informanter beskrev hur algoritmen blev en fast punkt i kaoset.

"Man har en tydlig algoritm i ryggmärgen som man kan luta sig emot. Man börjar med de här 5 inblåsningarna och sen kör man… det är någonting med den här inövade algoritmförfarandet då eller lathunden som gör att man känner en liten trygghet iallafall, att börja jobba utan att behöva tänka så mycket." (3)

5. 2. 2 Betydelsen av det kollegiala samspelet

Informanterna uppgav samstämmigt att det kollegiala samarbetet var den viktigaste delen i omhändertagandet. Att arbeta med rutinerade kollegor, vilka informanterna kände sig trygga med, gav en upplevelse av lugn i den kritiska situationen. De beskrev att kommunikationen i teamet var viktig och särskilt vikten av att alla vågade kommunicera sina åsikter och tankar. Genom ett väl fungerande samarbete och en gemensam ansvarsfördelning upplevde samtliga att när de som enskild sjuksköterska fick möjlighet att luta sig mot den kollektiva kompetensen reducerades den individuella osäkerheten. Flertalet informanter fann även en trygghet i antalet kollegor, när resurser tillkom blev situationen mer överblickbar och detta stärkte deras upplevelse av kontroll över situationen.

"Jag tänkte, fan, helvete, jävla skit. Och sen tänkte jag, men skönt, de kommer snart komma den andra bilen med supervana och trygga kollegor." (5)

En informant beskrev en upplevd ensamhet i beslutsfattandet, kombinerat med ett ansvar att samtidigt tvingas utföra merparten av de praktiska vårdmomenten själv. Informanten beskrev att när det kollegiala samspelet inte fungerade blev det ytterligare ett stressmoment i omhändertagandet.

"Jag hade också en kollega som jag kanske inte var helt synkad med. Det var ju en stressfaktor som ökade min stress väldigt mycket… min kollega var den största oron, det hade känts mycket bättre om jag hade haft en kollega så jag kunde släppa den stressen." (6)

5. 3 Emotionell belastning

Mötet med anhöriga ledde till emotionell belastning och en känsla av otillräcklighet. Anhörigas emotionella reaktioner samt logistiska dilemman under transport, såsom valet mellan egen säkerhet eller adekvat vård, utgjorde betydande etiska utmaningar.

5. 3. 1 Emotionell distansering för bibehållen handlingskraft

Informanterna redogjorde för att det framförallt var anhörigas reaktioner i händelsen som utgjorde det största hindret för emotionell kontroll. De beskrev en komplexitet och overklighetskänsla där tragiken trängde igenom det emotionella försvaret och då framför allt anhörigas reaktioner i situationen.

"Man är så jävla fokuserad så där finns inga känslor. Det enda som var jobbigt där och då var mammans skrik. Du var så fokuserad på din uppgift så att de känslorna angående barnet fanns inte med där och då utan det var bara att vi har en uppgift och det är att försöka rädda det här barnet. Egentligen, det jobbigaste där och då var ju mammans urskrik som pågick under hela HLR arbetet. Alltså hon var ju helt, det var skrik, det var bara skrik liksom. Nej, kunde inte tänka några känslor där och då." (8)

Flera av informanterna beskrev hur de aktivt valde att koppla bort sina egna känslor för att kunna arbeta med full kraft.

"Man blir ju bara radiostyrd. Man gör det man är tränad till att göra. Bara kör på, kör på, kör på… Nu går vi in i det här och kör 100%. Tänker inga känslor, utan vi kör bara." (1)

5. 3. 2 Anhörigas förtvivlan som operativ belastning

Flera informanter beskrev hur det uppstod en oro över hur den egna emotionella reaktionen skulle påverkas av de oförutsägbara emotionella reaktionerna från anhöriga och med detta utmaningen i att bibehålla yrkesmässig professionalism.

"Jag oroar mig för att föräldrarnas reaktioner ska påverka mig som sjuksköterska i det jobb jag ska göra. Jag oroar mig för att jag ska bli känslomässigt påverkad så att jag blir distraherad från mitt jobb." (4)

Informanterna beskrev att det i mötet med anhöriga uppkom en otillräcklighetskänsla. De upplevde en utmaning i att hantera och möta den kris anhöriga befann sig i samtidigt som omhändertagandet av barnet var tvunget att prioriteras. En strategi för att hantera denna otillräcklighetskänsla och försök till att inkludera och informera anhöriga var kontinuerlig öppen kommunikation av vårdinsatserna. Den visuella bekräftelsen av att allt tänkbart gjordes för barnet var en annan.

Informanterna såg de anhöriga som en självklar del i omhändertagandet och de redogjorde för en upplevelse av osäkerhet och utsatthet inför att ensam behöva bemöta och transportera anhöriga i akut kris när övriga teamet lämnar platsen med barnet.

"Föräldrabemötandet. Jag vet liksom inte om man borde prata eller veta hur man gör med folk som är i total chock. Alltså hur gör man? Det blir ändå i det larmet och den händelsen vi är i. För det är ju vi, ambulanspersonalen, som blir i den situationen. Alltså det är bara vi, oftast bara fyra personer och tre åker iväg och så står du där helt själv, hur gör man?" (8)

5. 3. 3 Prehospitalt dilemma

Informanterna beskrev en utmaning i att kvarstanna på plats och vårda när den primära impulsen var att söka trygghet i sjukhusvård.

"Man vill åka till sjukhuset… det är det svåraste att verkligen vara kvar på plats…men innerst inne vill man kasta in ungen i bilen och dra." (1)

Flera informanter redogjorde för hur komplexa beslut var tvungna att fattas beroende av tid till sjukhus samt säkerhet under transport. Insikten om att HLR under transport är bristfällig, skapade ett risktagande och en ohållbar arbetssituation där de tvingades välja mellan bristfällig vård och egen säkerhet.

"Sen börja tänka på kompressioner under färd. 40 minuters bilkörning, blåljus, det är en mardröm, det går ju inte. Ska jag stå obältad? Skulle jag bälta mig? Då får vi välja risker där, för vi kan inte göra kompressioner under transport på ett bra sätt." (6)

5. 4 Bearbetning och finna ro efter insatsen

När den akuta insatsen avslutades påbörjades en process för återhämtning och personlig bearbetning av händelsen.

5. 4. 1 Från professionell skärpa till emotionell reaktion

När det akuta arbetet var över och situationens omfattning sjönk in beskrev informanterna en mental trötthet efter en extrem arbetssituation.

"Mitt i alltihopa det här så kände man väl emotionellt att fan vilken jobbig arbetsdag jag haft idag och det var väldigt väldigt tungt." (6)

Informanterna beskrev en ambivalens av flera motstridiga känslor, exempelvis glädje, sorg och lättnad samtidigt. Glädje när situationens utfall blev positivt, sorg över händelsens påverkan på alla inblandade och lättnad över att vara klar med sin insats.

"Glädjen efter att barnet vaknar till. Att man känner, vi har faktiskt gjort skillnad. Vi har räddat liv. Tagit tillbaka barnet till livet." (2)

5. 4. 2 Emotionellt efterspel

Några informanter uppgav att erfarenheten av hjärtstoppsituationen på barnet utgör en värdefull kunskapsbas och mental beredskap inför framtida liknande situationer. En informant visade på vikten av att landa i händelsen med struktur, genom debriefing eller samtal.

"Det svåraste är väl egentligen efteråt. Hur man hanterar det efteråt egentligen. Känner man sig tryggare med att utföra HLR på barn så kommer det bli lättare att bearbeta det efteråt för man vet att man gjort allt man kan och allting som står i ens makt. Man behöver också lite stöd och backning efteråt, förståelse för vad man har gjort, för det kom efteråt. Vad har jag gjort? Där och då gjorde man bara. Ryggmärgsreflexmässigt. Landa i det med struktur tror jag är viktigt" (5)

En faktor informanterna beskrev som viktig för att nå acceptans av utfallet var känslan av att ha uppfyllt sitt professionella ansvar. Detta uppnåddes genom insikten om att teamet hade gjort sitt yttersta med de resurser och förutsättningar som stod till förfogande. Informanterna beskrev en oro för att den emotionella tyngden i ett omhändertagande av ett barn med hjärtstopp skulle leda till långvarig psykisk påverkan och svårigheter att släppa händelsen i efterhand. Nya liknande händelser kunde trigga minnesbilder och ånyo en upplevelse av emotionell påverkan. En informant sa:

"Och jag känner nu också att det är tungt. Man blir berörd. Jag tänker på det där barnet väldigt ofta. Varje gång man hör en kollega åka på barnhjärtstopp så väcks det till liv och så är det inte på vuxna. Barn ska leva, så är det ju bara." (6)

5. 5 Att navigera i det extraordinära

Sjuksköterskans upplevelse vid hjärtstopp hos barn handlar om att acceptera att situationen är extraordinär och att man aldrig blir fullärd. Det är en situation som präglas av kraftiga emotionella reaktioner som trängs tillbaka för att kunna utföra omhändertagandet. Med hjälp av förutbestämda handlingsplaner och stöd av kollegor skapas förutsättningar för att hantera en

krävande medicinsk situation där även anhörigas emotionella reaktioner utgör en utmaning. Det är en händelse som kan följa sjuksköterskan långt efter att insatsen är avslutad.

6. Diskussion

6. 1 Metoddiskussion

Val av lämplig metod för datainsamling är viktigt för att skapa trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Studien har en kvalitativ induktiv ansats vilket styrker trovärdigheten då det är en lämplig metod för att undersöka upplevelser och speciellt emotionella sådana.

Urvalsmetoden grundade sig på bekvämlighetsurval, vilket enligt Polit och Beck (2021) är ett bra inledande sätt för att hitta frivilliga som vill delta i studien. Valet av urvalsmetod motiveras främst med att nå deltagare inom den givna tidsramen. Bekvämlighetsurval innebär dock en hög risk för selektionsbias (Ahmed, 2024). En risk med bekvämlighetsurvalet är att endast sjuksköterskor som kände sig trygga i sin bearbetning av situationen valde att delta vilket enligt Elo et al. (2014) kan påverka trovärdigheten. Då en avsaknad av tillräckligt många deltagare fanns användes snöbollsurval där deltagarna tillfrågades om det fanns kollegor som varit med om en situation relevant för studien, dessa kontaktades sedan. Snöbollsurval kan medföra att ett homogent urval uppstår (Ahmed, 2024), dock rekryterades deltagare från två olika regioner vilket minskade risken för ett homogent resultat vilket stärker studiens överförbarhet. Enligt Elo et al. (2014) ökar spridningen av urvalet även trovärdigheten. Val av regioner där intervjuer genomfördes utgick från studiens begränsade resurser och tidsram. En intervjuguide upprättades och en provintervju utfördes för att säkerställa att frågorna svarade till studiens syfte. En semistrukturerad intervju gav deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017), men säkerställde samtidigt att det valda ämnet besvarades. Det gav också en flexibilitet att ställa följdfrågor under intervjun. Tillsammans stärker detta giltigheten (Polit & Beck, 2021).

Deltagarna i studien har en professionell relation till intervjuaren, vilket kan ses som ett etiskt dilemma. Detta riskerar att skapa en intervjudynamik som påverkar datainsamlingen. Yrkesrelationen kan dock även ses som en styrka då den bidrar med en grundläggande tillit vilket kan sänka trösklarna för ett öppet och djupare samtal. Samtidigt finns en risk för självcensur där informanterna kan känna ett behov av att upprätthålla en professionell fasad för att skydda sig själva inför ett kommande samarbete som kollegor (McConell-Henry et al., 2010).

För att stärka tillförlitligheten spelades intervjuerna in med diktafon då endast anteckningar kan bli inkompletta beroende av intervjuarens förhållningssätt eller minne. Att anteckna under intervjun kan även störa intervjuarens koncentration och kan leda till distraktion och förmågan att få ett flöde i intervjun minskar (Polit & Beck, 2021).

Att läsa materialet flertalet gånger både enskilt och tillsammans är en förutsättning för att kunna göra en korrekt bearbetning av materialet (Flanagan & Beck, 2025). Bedömning av mättnad var genomgående genom hela studien och en öppenhet fanns för att antalet deltagare eventuellt behövde justeras. Trots ett begränsat antal deltagare var datamaterialet rikt på information vilket möjliggjorde en djup analys.

För att öka studiens tillförlitlighet beskrivs analysprocessen (tabell 1) vilket ger läsaren möjlighet att följa stegen från rådata till färdiga kategorier. Detta ökar transparensen och visar att resultatet är djupt förankrat i informanternas berättelser (Elo & Kyngäs, 2008). Att

genomgående använda citat stärker studiens bekräftelsebarhet, då det ger läsaren möjlighet att själv avgöra om tolkningarna är rimliga i förhållande till vad informanterna faktiskt sagt (Elo et al., 2014).

Författarna till studien har en professionell bakgrund som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Denna kliniska erfarenhet var en tillgång under intervjuerna för att skapa tillit och förstå kontextuella nyanser, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan stärka studiens trovärdighet. Samtidigt finns en risk att egna värderingar och kliniska lösningar kunnat färga analysen. Då diktafon användes under intervjuerna kunde de transkriberas ordagrant och på så sätt säkerställa att analysen baserades på informanternas faktiska uttalanden snarare än författarnas minnesbilder (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna har kontinuerligt reflekterat över sin förförståelse och återkommande kontrollerat kategorierna mot rådatan. Detta för att eftersträva att resultatet speglar informanternas perspektiv och inte författarnas förförståelse (Elo et al., 2014). Genom att kodning och kategorier utfördes gemensamt och diskuterades tills samstämmighet uppnåddes, minimerades risken för att individuella förutfattade meningar påverkade resultatet, detta stärker bekräftelsebarheten (Elo et al., 2014). Med kontinuerlig reflektion och diskussion har författarna strävat efter att begränsa förförståelsens inflytande och därigenom förbättra kvaliteten på studien. Genom att tydligt beskriva urval, datainsamling och analysprocessen underlättas överförbarheten av studien (Elo & Kyngäs, 2008), men det är läsarens bedömning som avgör om resultaten är överförbara till ett annat sammanhang (Elo et al., 2014).

6. 2 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvården.

Resultatet visar på upplevelsen av en krävande yrkessituation med stark emotionell belastning och krav på hög klinisk kompetens i en tidskritisk situation. Tidigare forskning visar att pediatriska larm hör till de mest stressfyllda uppdragen för ambulanspersonal (Näsström et al., 2023). Denna anspänning förstärks av att detta är en sällanhändelse, och trots lång yrkeserfarenhet upplever informanter kompetensmässig utsatthet. Informanterna beskriver samstämmigt att det är ett uppdrag där det inte finns utrymme för misstag, allting måste fungera. Känslan bekräftas också av Nordén et al. (2014) som redogör för hur sjuksköterskor hade känslan av att ingenting fick gå fel.

För att bemästra det initiala kaoset beskriver informanterna hur de kliver in i en roll och aktivt väljer bort sina känslor för att kunna fokusera på uppgiften. Genom att arbeta automatiserat och förlita sig på inövade algoritmer skapas en fast punkt i kaoset. Dessa använder informanterna för att reducera osäkerhet och skapa en medicinsk strategi under den tidspress som råder. Detta metodiska tillvägagångssätt möjliggör en emotionell distansering som krävs för att bibehålla handlingskraft. Det bekräftas av Uhrecký et al. (2025) som visar hur ambulanspersonalen måste gå in i sin professionella roll för att klara av den emotionella situationen. Informanterna beskriver sig som radiostyrda detta hjälper dem att hantera mentalt brus och helt fokusera på den medicinska uppgiften. Vicente et al. (2021) beskriver hur sjuksköterskan sätter på sig en mask och lämnar sina känslor utanför uppdraget. Benner (1993) menar att trots lång yrkeserfarenhet innebär den begränsade kliniska exponeringen för hjärtstopp hos barn att sjuksköterskan tvingas backa från en intuitiv expertnivå till en mer regelstyrd kompetensnivå. Algoritmen blir då det nödvändiga stödet för bibehållen handlingskraft när den kliniska blicken

inte hunnit utvecklas för just denna specifika patientgrupp. När situationen saknar igenkänningsmönster tvingas även den erfarne att återgå till en lägre kompetensnivå.

I resultatet framkommer att det kollegiala samarbetet framstår som den viktigaste faktorn för trygghet. När informanterna känner kollegial trygghet reduceras den individuella osäkerheten, vilket understryker vikten av väl fungerande teamarbete i sällanhändelser. Det framkommer även att när samarbetet inte fungerar blir kollegan och det bristande teamarbetet en stressfaktor. Det finns beskrivet att i fall där teamet har olika yrkeserfarenhet uppstår en upplevd ensamhet och maktlöshet hos den mer erfarna kollegan som känner press att även övervaka och tänka för den mindre erfarna kollegan (Malmsten et al., 2025). Detta bekräftas av Näsström et al. (2023) samt Uhrecký et al. (2025) där den senare beskriver hur ambulanspersonalen ges mental avlastning när kollegan ger trygghet. Enligt Benner (1993) har experten en förmåga att se helhetsmönster och agera intuitivt, medan novisen förlitar sig till enskilda detaljer och regler. När teamet har olika erfarenhetsnivåer uppstår en asymmetri som Benner beskriver som krävande, den mer erfarna kollegan tvingas inte bara bära sitt eget ansvar utan även agera mentor och övervaka den mindre erfarna. Detta grundar sig i att experten ser helhetsmönster som novisen ännu inte kan uppfatta, vilket skapar en kognitiv påfrestning hos den erfarne som måste verbalisera och kontrollera varje steg i processen (Benner 1993).

En av de största utmaningarna som identifieras är mötet med anhöriga. Anhörigas emotionella reaktioner utgör ett element av osäkerhet som hotar den professionella rollen. Resultatet belyser ett etiskt dilemma där informanterna känner en otillräcklighet i att prioritera barnets vård och samtidigt ge stöd till föräldrarna vilket i förlängningen kan leda till etisk stress. Nordén et al. (2014) redogör för hur sjuksköterskor hade en känsla av otillräcklighet då de hade minst två personer att vårda, barnet och anhörig. Näsström et al. (2023) finner att sjuksköterskor oroar sig för vilket tillstånd föräldrarna kommer vara och hur detta påverkar omhändertagandet av barnen. Samma resultat framkommer i denna studie.

En aspekt i resultatet är de logistiska utmaningarna under transport. Informanterna beskriver hur beslutet att tvingas välja mellan att utföra bristfällig HLR obältad i hög fart eller att prioritera egen säkerhet skapar ett etiskt dilemma. Denna konflikt mellan medicinska behov och personlig säkerhet är ett dokumenterat riskområde inom ambulanssjukvården. Cash et al. (2019) visar att användning av bilbälte minskar vid transport av kritiskt sjuka patienter. Informanterna beskriver hur den emotionella reaktionen kommer när uppdraget är slutfört. Näsström et al. (2023) beskriver hur sjuksköterskorna vid patientfall med dödlig utgång kände stolthet och tillfredsställelse över sina egna insatser i en svår situation samtidigt som de kände sorgsenhet och sympati för patienten och familjen. Insikten om att ha gjort sitt yttersta hjälper informanterna att släppa fallet och gå vidare även om det ofta stannar kvar på ett sätt som det inte gör vid liknande fall med vuxna. Det bekräftas av Uhrecký et al. (2025) som belyser att sjuksköterskorna kan bära med sig dessa fall resten av livet.

7. Slutsatser

Att möta barn med hjärtstopp i ambulanssjukvården är en extraordinär sällanhändelse där sjuksköterskan tvingas backa från en intuitiv expertnivå till ett mer regelstyrt och automatiserat arbetssätt. Genom emotionell distansering och förlita sig på inövade algoritmer skapas den struktur som krävs för att bibehålla handlingskraft i kaoset. Den viktigaste faktorn för trygghet är det kollegiala samarbetet. Sammanfattningsvis krävs både mental förberedelse, goda kunskaper i det akuta omhändertagandet och ett välfungerande team för att hantera den starka anspänningen och de höga kraven på klinisk kompetens.

8. Kliniska implikationer

För att stärka patientsäkerheten vid hjärtstopp hos barn bör regelbunden simuleringsträning i hjärtstoppssituationer gällande barn genomföras, vilket möjliggör att livsviktiga algoritmer sitter i ryggmärgen trots låg klinisk exponering. För att sjuksköterskan ska ges möjlighet att upprätthålla handlingskraft trots hög kognitiv belastning är det viktigt med goda kunskaper gällande praktiska moment, vilket uppnås genom kontinuerlig praktisk övning. Sjuksköterskor verksamma inom ambulansverksamheten bör även ges tid för teamträning för att hantera asymmetriska team, där den erfarna kollegan ges specifikt stöd i sin roll som mentor och ledare under kritiska larm. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård som inte har erfarenhet av att vårda barn med hjärtstopp kan ta del av denna studie för att ges en inblick i komplexiteten och kan motivera noviser till ytterligare träning och mental förberedelse.

9. Fortsatt forskning

Förslag på framtida forskning är att se om utökad utbildning gällande kritiskt sjuka barn samt möjlighet till att öva praktiska moment i reell vårdmiljön leder till minskad stress och ökad trygghet hos sjuksköterskorna i hjärtstoppsituationer hos barn. Framtida studier kan undersöka hur teamets sammansättning, yrkeserfarenhet och kommunikation påverkar sjuksköterskornas upplevelse av trygghet vid hjärtstopp hos barn. Det vore värdefullt att undersöka anhörigas upplevelser av hjärtstopp hos barn inom ambulanssjukvården för att utveckla stödjande strategier som möter anhörigas behov. Vidare behövs forskning om vilka former av debriefing och psykologiskt stöd som bäst främjar bearbetning och återhämtning hos sjuksköterskan efter dessa händelser.

Referenslista

Ahmed, S K. (2024). How to choose a sampling technique and determine sample size for research: A simplified guide for researchers. *Oral Oncology Reports,12*. https://doi.org/10.1016/j.oor.2024.100662

Benner, P. (1993). *Från novis till expert: Mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet* (T. Grundberg & B. Hedén, Övers.). Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1984)

Bohström, D., Carlström, E., & Sjöström, N. (2017). Managing stress in prehospital care: Strategies used by ambulance nurses. *International Emergency Nursing*, *32*, 28–33. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2016.08.004

Bettencourt, A. P., Gorman, M., & Mullen, J. E. (2021). Pediatric resuscitation. *Critical Care Nursing Clinics of North America*, *33*(3), 287–302. https://doi.org/10.1016/j.cnc.2021.05.005

Bäckström, D., Jörnvall, H., Strandqvist, E., Ahlerup, R., & Rubenson Wahlin, R. (2024). Prevalence and severity of pediatric cases in Stockholm's physician-staffed prehospital units: a retrospective cohort study. *BMC emergency medicine*, *24*(1), 211. https://doi.org/10.1186/s12873-024-01126-3

Cash, R. E., Crowe, R. P., Rivard, M. K., Crowe, E., Knorr, A. C., Panchal, A. R., & Kupas, D. F. (2019). Seat belt use in the ambulance patient compartment by emergency medical services professionals is low regardless of patient presence, seating position, or patient acuity. *Journal of safety research*, *71*, 173–180. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.10.003

Djakow, J., Turner, N. M., Skellett, S., Buysse, C. M. P., Cardona, F., de Lucas, N., Castillo, J. D., Kiviranta, P., Lauridsen, K. G., Markel, F., Martinez-Mejias, A., Roggen, I., Biarent, D., & ERC Paediatric Life Support Writing Group collaborators (2025). European Resuscitation Council Guidelines 2025 Paediatric Life Support. *Resuscitation*, *215 Suppl 1*, 110767. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.110767

Elo, S., & Kyngäs, H., (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell)*, *62*(1), 107–115. https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness: A Focus on Trustworthiness. *Sage Open*, *4*(1). https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Etikprövningsmyndigheten. (2023). https://etikprovningsmyndigheten.se/vagledning/

Flanagan, J. & Beck, C.T. (2025) *Polit & Beck´s nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (12th ed.). Wolters Kluwer.

Fovaeus, H., Holmen, J., Mandalenakis, Z., Herlitz, J., Rawshani, A., & Castellheim, A. G. (2024). Out-of-hospital cardiac arrest: Survival in children and young adults over 30 years, a nationwide registry-based cohort study. *Resuscitation*, *195*, 110103. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.110103

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, *24*(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001-

Jepsen, K., Rooth, K., & Lindström, V. (2019). Parents' experiences of the caring encounter in the ambulance service-A qualitative study. *Journal of clinical nursing*, *28*(19-20), 3660–3668. https://doi.org/10.1111/jocn.14964

Jeruzal, J. N., Boland, L. L., Frazer, M. S., Kamrud, J. W., Myers, R. N., Lick, C. J., & Stevens, A. C. (2019). Emergency Medical Services Provider Perspectives on Pediatric Calls: A Qualitative Study. *Prehospital emergency care*, *23*(4), 501–509. https://doi.org/10.1080/10903127.2018.1551450

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). *Den kvalitativa forskningsintervjun* (3. uppl.). Studentlitteratur.

Larsson, R., & Engström, Å. (2013). Swedish ambulance nurses' experiences of nursing patients suffering cardiac arrest. *International journal of nursing practice*, *19*(2), 197–205. https://doi.org/10.1111/ijn.12057

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund-Nielsen & M. Granskär (Red.), *Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård*. (3. uppl., s. 211-226). Studentlitteratur.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197/

Malmsten, E., Hammarström, H., Hallgren, J., & Snögren, M. (2025). "There are two of us": Registered nurses' experience of teamwork and working alone in the Swedish ambulance service-a qualitative interview study. *International emergency nursing*, *78*, 101550. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2024.101550

McConnell-Henry, T., James, A., Chapman, Y., & Francis, K. (2010). Researching with people you know: Issues in interviewing. *Contemporary Nurse*, *34*(1), 2–9. https://doi-org.db.ub.oru.se/10.5172/conu.2009.34.1.002

Nordén, C., Hult, K., & Engström, Å. (2014). Ambulance nurses' experiences of nursing critically ill and injured children: A difficult aspect of ambulance nursing care. *International Emergency Nursing*, *22*(2), 75–80. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2013.04.003

Näsström, M., Junehag, L., Häggström, M., & Holmström-Rising, M. (2023). An emotional journey when encountering children in prehospital care: Experiences from ambulance nurses. *International emergency nursing*, *66*, 101239. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101239

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Socialstyrelsen. (2009). *Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.* (SOSFS 2009:10) https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-

riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200910-om-ambulanssjukvard-m.m/

Uhrecký, B., Kučerová, V., & Paksi, D. (2025). "You treat your stress by doing what you're supposed to do": a qualitative inquiry into emotion regulation of paramedics and paramedic students in critical incidents. *BMC emergency medicine*, *25*(1), 73. https://doi.org/10.1186/s12873-025-01228-6

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed* (Rapport nr VR1708). God forskningssed (2017) - Vetenskapsrådet

Vicente, V., Jansson, J., Wikström, M., Danehorn, E., & Rubenson Wahlin, R. (2021). Prehospital Emergency Nurses' coping strategies associated to traumatic experiences. *International emergency nursing*, *59*, 101083. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2021.101083

Öberg, M., Vicente, V., & Wahlberg, A. C. (2015). The Emergency Medical Service personnel's perception of the transportation of young children. *International emergency nursing*, *23*(2), 133–137. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.06.192

Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

- Definierar du dig som man, kvinna eller annat?
- Antal år du arbetat som sjuksköterska?
- Antal år inom ambulansen som sjuksköterska?
- Vilken utbildning har du?

Huvudfrågor:

1. Berätta om dina tankar gällande hjärtstopp hos barn?

2. Berätta om en situation där du varit delaktig i omhändertagandet av ett barn med hjärtstopp?

   Följdfrågor; Hur kändes det för dig?

   Vilka känslor väckte det hos dig?

3. Finns det något speciellt som du oroar dig för?

4. Varför oroar du dig för just detta?

5. Finns det något du känner dig trygg med?

6. Vad är det som gör att du känner dig trygg i detta?

7. Berätta vad du tänker under framkörningen?

8. Är det något du skulle vilja berätta som vi inte berört under den här intervjun vad gäller svårigheter vid omhändertagandet av barn med hjärtstopp?